REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO: PARANA
MUNICÍPIO: IBEMA

Relatório Anual de Gestão
2025

EROILDA ALVES DE OLIVEIRA
Secretário(a) de Saúde

Sumário

1. Identificação
- 1.1. Informações Territoriais
- 1.2. Secretaria de Saúde
- 1.3. Informações da Gestão
- 1.4. Fundo de Saúde
- 1.5. Plano de Saúde
- 1.6. Informações sobre Regionalização
- 1.7. Conselho de Saúde
- 1.8. Casa Legislativa

2. Introdução

3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade
- 3.1. População estimada por sexo e faixa etária
- 3.2. Nascidos Vivos
- 3.3. Principais causas de internação por local de residência
- 3.4. Mortalidade por grupos de causas

4. Dados da Produção de Serviços no SUS
- 4.1. Produção de Atenção Básica
- 4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos
- 4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização
- 4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos
- 4.5. Produção de Assistência Farmacêutica
- 4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS
- 5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão
- 5.2. Por natureza jurídica
- 5.3. Consórcios em saúde

6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

7. Programação Anual de Saúde - PAS
- 7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores

8. Indicadores de Pactuação Interfederativa

9. Execução Orçamentária e Financeira
- 9.1. Execução da programação por fonte de recurso, subfunção e categoria econômica
- 9.2. Indicadores financeiros
- 9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)
- 9.4. Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo, segundo bloco de financiamento e programa de trabalho
- 9.5. Relatório de Execução de Recursos Repassados por Emenda Parlamentar

10. Auditorias

11. Análises e Considerações Gerais

12. Recomendações para o Próximo Exercício

1. Identificação

1.1. Informações Territoriais

UF	PR
Município	IBEMA
Região de Saúde	10ª RS Cascavel
Área	145,44 Km²
População	6.343 Hab
Densidade Populacional	44 Hab/Km²

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
Data da consulta: 15/12/2025

1 .2. Secretaria de Saúde

Nome do Órgão	SMS DE IBEMA
Número CNES	6772307
CNPJ	A informação não foi identificada na base de dados
CNPJ da Mantenedora	80881931000185
Endereço	RUA PARANAVAI S/N
Email	sms@pibema.pr.gov.br
Telefone	4532381865

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 15/12/2025

1 .3. Informações da Gestão

Prefeito(a)	VIVIANE COMIRAN
Secretário(a) de Saúde cadastrado no período	EROILDA ALVES DE OLIVEIRA
E-mail secretário(a)	batis-frios@hotmail.com
Telefone secretário(a)	41988564125

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 15/12/2025
Período de referência: 01/09/2025 - 31/12/2025

1.4. Fundo de Saúde

Instrumento de criação	LEI
Data de criação	08/1991
CNPJ	09.260.523/0001-41
Natureza Jurídica	FUNDO PUBLICO DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL
Nome do Gestor do Fundo	Eroilda Alves de Oliveira

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 15/12/2025

1.5. Plano de Saúde

Período do Plano de Saúde	2022-2025
Status do Plano	Aprovado

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 20/10/2022

1.6. Informações sobre Regionalização

Região de Saúde: 10ª RS Cascavel

Município	Área (Km²)	População (Hab)	Densidade
ANAHY	102.648	2971	28,94
BOA VISTA DA APARECIDA	256.296	8023	31,30
BRAGANEY	343.321	4745	13,82
CAFELÂNDIA	271.724	20145	74,14
CAMPO BONITO	433.836	3997	9,21
CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES	275.748	14776	53,59
CASCAVEL	2100.105	368195	175,32
CATANDUVAS	581.754	10621	18,26
CORBÉLIA	529.385	17933	33,88
CÉU AZUL	1179.442	11255	9,54
DIAMANTE DO SUL	359.945	3147	8,74
ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU	326.446	4880	14,95
FORMOSA DO OESTE	275.712	7763	28,16
GUARANIAÇU	1225.607	13770	11,24
IBEMA	145.442	6343	43,61
IGUATU	106.937	2156	20,16
IRACEMA DO OESTE	81.538	2328	28,55
JESUÍTAS	247.496	10954	44,26
LINDOESTE	361.368	5217	14,44
NOVA AURORA	474.011	14331	30,23
QUEDAS DO IGUAÇU	821.503	31423	38,25
SANTA LÚCIA	116.857	3638	31,13
SANTA TEREZA DO OESTE	326.917	13938	42,63
TRÊS BARRAS DO PARANÁ	504.172	11157	22,13
VERA CRUZ DO OESTE	327.084	8178	25,00

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
Ano de referência: 2025

1 .7. Conselho de Saúde

Intrumento Legal de Criação	DECRETO	
Endereço	Rua Paranavaí	
E-mail		
Telefone		
Nome do Presidente	Luiz Narciso Talini	
Número de conselheiros por segmento	**Usuários**	4
	Governo	2
	Trabalhadores	2
	Prestadores	0

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Ano de referência:

1 .8. Casa Legislativa

1º RDQA	2º RDQA	3º RDQA
Data de Apresentação na Casa Legislativa	**Data de Apresentação na Casa Legislativa**	**Data de Apresentação na Casa Legislativa**

- Considerações

O crescimento da população entre 2010 e 2022 foi modesto (+2,51 %), indicando estabilidade demográfica. ¿

A densidade é relativamente baixa, característica comum em municípios de pequeno porte e com grandes áreas territoriais em regiões rurais.

A proporção de crianças entre 0 e 6 anos (¿ 10,04 %) mostra presença de população jovem, o que implica em demanda por serviços de saúde materno-infantil, educação infantil e creches.

O número de domicílios e o tamanho médio de moradores por domicílio também são dados importantes para planejamento de infraestrutura, saneamento, habitação etc.

2. Introdução

- Análises e Considerações sobre Introdução

Este instrumento contempla as informações referentes as ações de saúde, suas pactuações e metas alcançadas, bem como prestação de contas financeiras no ano de 2025

3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade

A disponibilização dos dados do SINASC, SIM e SIH, no DGMP, depende do prazo de publicação, respectivamente, pelos DAENT/SVSA e DRAC/SAES

3.1. População estimada por sexo e faixa etária

Período: 2025

Faixa Etária	Masculino	Feminino	Total
0 a 4 anos	210	204	414
5 a 9 anos	236	236	472
10 a 14 anos	239	230	469
15 a 19 anos	217	220	437
20 a 29 anos	412	463	875
30 a 39 anos	398	418	816
40 a 49 anos	407	436	843
50 a 59 anos	408	427	835
60 a 69 anos	318	343	661
70 a 79 anos	169	183	352
80 anos e mais	72	97	169
Total	**3.086**	**3.257**	**6.343**

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE (DataSUS/Tabnet)
Data da consulta: 09/03/2026.

3.2. Nascidos Vivos

Número de nascidos vivos por residência da mãe.

Unidade Federação	2021	2022	2023	2024
IBEMA	79	83	85	103

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC)
Data da consulta: 09/03/2026.

3.3. Principais causas de internação por local de residência

Morbidade Hospitalar de residentes, segundo capítulo da CID-10.

Capítulo CID-10	2021	2022	2023	2024	2025
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	128	49	38	97	51
II. Neoplasias (tumores)	95	87	93	63	59
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	5	18	10	7	4
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	7	10	13	16	7
V. Transtornos mentais e comportamentais	9	5	13	12	7
VI. Doenças do sistema nervoso	8	6	17	11	29
VII. Doenças do olho e anexos	6	5	10	8	2
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	1	1	2
IX. Doenças do aparelho circulatório	83	69	106	158	155
X. Doenças do aparelho respiratório	62	127	97	128	116
XI. Doenças do aparelho digestivo	37	84	84	119	134
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	1	6	3	7	11

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	2	12	14	30	34
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	28	20	37	49	67
XV. Gravidez parto e puerpério	55	64	72	104	108
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	12	9	8	16	21
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	2	4	1	7	4
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	3	10	22	17	24
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	34	69	92	129	95
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	-	-	-	-	-
XXI. Contatos com serviços de saúde	3	11	13	34	30
CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido	-	-	-	-	-
Total	**580**	**665**	**744**	**1.013**	**960**

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 09/03/2026.

3.4. Mortalidade por grupos de causas

Mortalidade de residentes, segundo capítulo CID-10

Capítulo CID-10	2021	2022	2023	2024
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	22	5	2	1
II. Neoplasias (tumores)	14	8	6	13
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	-	-	-	-
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	1	3	2	5
V. Transtornos mentais e comportamentais	-	-	-	-
VI. Doenças do sistema nervoso	1	3	1	2
VII. Doenças do olho e anexos	-	-	-	-
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	-	-
IX. Doenças do aparelho circulatório	25	12	11	18
X. Doenças do aparelho respiratório	7	10	8	9
XI. Doenças do aparelho digestivo	3	2	6	3
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	-	1	-	1
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	1	-	-	1
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	-	1	3	1
XV. Gravidez parto e puerpério	-	-	-	1
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	1	-	1	-
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	2	-	1	-
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	1	-	-	-
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	-	-	-	-
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	10	7	10	13
XXI. Contatos com serviços de saúde	-	-	-	-
XXII.Códigos para propósitos especiais	-	-	-	-
Total	**88**	**52**	**51**	**68**

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET)
Data da consulta: 09/03/2026.

- Análises e Considerações sobre Dados Demográficos e de Morbimortalidade

ara evitar mortes por causas sensíveis, a chave é fortalecer a atenção primária à saúde e garantir acesso rápido e resolutivo à rede de atenção:

1. Promoção da saúde e prevenção
   a)Vacinação em dia para prevenir mortes por doenças imunopreveníveis (sarampo, coqueluche, influenza, COVID-19, hepatites).
   b)Campanhas educativas de higiene, alimentação saudável, atividade física, abandono do tabagismo e álcool em excesso.
   c)Ações de vigilância epidemiológica e controle de vetores (dengue, zika, chikungunya), monitoramento de surtos e contato ativo de casos.
2. Atenção primária resolutiva
   a)Acompanhamento de hipertensos e diabéticos com consultas regulares, adesão a medicamentos, exames periódicos, plano terapêutico.
   b)Pré-natal qualificado e início precoce, consultas suficientes, exames, orientação sobre sinais de risco e encaminhamento oportuno.
   c)Saúde da criança com acompanhamento do crescimento, alimentação adequada, manejo precoce de diarréia e infecções respiratórias.
   d)Saúde do idoso e vacinação, controle de doenças crônicas, prevenção de quedas, suporte familiar.
   e) Capacitação das equipes e protocolos clínicos, manejo rápido de emergências na unidade.
3. Acesso a serviços especializados e hospitalares
   a)Encaminhamento ágil quando a atenção básica identifica risco ou complicação.
   b)Regulação eficiente para garantir vaga hospitalar em tempo adequado.
   c)Unidades de pronto atendimento (UPA) articuladas com a atenção primária e hospitais.
4. Gestão e monitoramento
   a)Mapear óbitos por causas sensíveis no município eidentificar quais são mais freqüentes (ex.: AVC, pneumonia, complicações do parto).
   b)Usar dados do SIM, SIAB/e-SUS e RAG para avaliar indicadores e planejar ações.
   c)Educação permanente das equipes revisando protocolos de manejo de agravos mais comuns.
5. Ações intersetoriais
   a)Saneamento básico e água tratada reduzem diarreias e infecções.
   b)Educação aumenta adesão ao cuidado e ao uso correto dos serviços de saúde.
   c)Assistência social apoio a famílias vulneráveis que têm maior risco de adoecer e morrer precocemente.

Em resumo: a maioria dessas mortes pode ser evitada com prevenção, acompanhamento contínuo de condições crônicas, vacinação, acesso rápido ao diagnóstico e tratamento, além de integração entre atenção primária, urgência e hospital.

4. Dados da Produção de Serviços no SUS

A disponibilização dos dados do SIS AB, SIA e SIH, no DGMP, depende do prazo de publicação, respectivamente, pelos DESF/SAPS e DRAC/SAES

4.1. Produção de Atenção Básica

Tipo de Produção	Quantidade
Visita Domiciliar	7.773
Atendimento Individual	16.272
Procedimento	29.150
Atendimento Odontológico	2.003

Fonte: Sistema de informação em Saúde para a Atenção Básica – SISAB

4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos

Caráter de atendimento: Urgência

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informacões Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Acoes de promocao e prevencao em saude	-	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnostica	-	-	-	-
03 Procedimentos clinicos	-	-	-	-
04 Procedimentos cirurgicos	-	-	-	-
05 Transplantes de orgaos, tecidos e celulas	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Orteses, proteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Acoes complementares da atencao a saude	-	-	-	-
09				
Procedimentos para Ofertas de Cuidados Integrados"	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 27/03/2026.

4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização

Não há informações cadastradas para o período

4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informacões Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Acoes de promocao e prevencao em saude	-	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnostica	-	-	-	-
03 Procedimentos clinicos	-	-	-	-
04 Procedimentos cirurgicos	-	-	-	-
05 Transplantes de orgaos, tecidos e celulas	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-

07 Orteses, proteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Acoes complementares da atencao a saude	-	-	-	-
09				
Procedimentos para Ofertas de Cuidados Integrados"	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 27/03/2026.

4.5. Produção de Assistência Farmacêutica

Esse item refere-se ao componente especializado da assistência farmacêutica, sob gestão da esfera estadual.
Portanto, não há produção sob gestão municipal.

4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

Não há informações cadastradas para o período
Data da consulta: 27/03/2026.

- Análises e Considerações sobre Dados da Produção de Serviços no SUS

Neste quadro verificarmos a falta de dados. Segue abaixo alguns dados retirados do E-sus que contemplam as informações:

Procedimentos	Total
Aferição de PA	5054
Aferição de temperatura	4777
Curativo simples	1222
Glicemia capilar	1338
Medição de altura	4526
Medição de peso	4830
Total	21747

atendimentos médicos no hospital municipal no ano de 2025: 11.853

atendimentos da enfermagem no hospital municipal no ano de 2025: 5.053

atendimentos médicos na UBS e USF no ano de 2025: 12.037

atendimentos da enfermagem na UBS e USF no ano de 2025: 3.500

OBS: durante o ano de 2025 tivemos algumas falhas na transmissão de dados no nível estadual, podendo os dados não ser fidedignos

5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão

A disponibilização dos dados do SCNES, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo DRAC/SAES.

Período 12/2025

Rede física de estabelecimentos de saúde por tipo de estabelecimentos				
Tipo de Estabelecimento	**Dupla**	**Estadual**	**Municipal**	**Total**
HOSPITAL GERAL	0	1	0	1
POLO ACADEMIA DA SAUDE	0	0	1	1
CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE	0	0	1	1
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	0	0	2	2
CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	0	1	0	1
UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)	0	1	0	1
Total	**0**	**3**	**4**	**7**

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 15/12/2025.

5.2. Por natureza jurídica

Período 12/2025

Rede física de estabelecimentos de saúde por natureza jurídica				
Natureza Jurídica	**Municipal**	**Estadual**	**Dupla**	**Total**
ADMINISTRACAO PUBLICA				
MUNICIPIO	4	1	0	5
ENTIDADES EMPRESARIAIS				
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	0	1	0	1
ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				
ASSOCIACAO PRIVADA	0	1	0	1
Total	**4**	**3**	**0**	**7**

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 15/12/2025.

5.3. Consórcios em saúde

Período 2025

Participação em consórcios			
CNPJ	**Natureza**	**Area de atuação**	**Participantes**
03273207000128	Direito Público	Compra de medicamentos	PR / IBEMA
17420047000107	Direito Público	Urgência e emergência	PR / IBEMA
00944673000108	Direito Público	Atenção psicossocial Atenção odontológica Urgência e emergência Atenção hospitalar Serviços de apoio ao diagnóstico Consulta médica especializada	PR / IBEMA

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 15/12/2025.

- Análises e Considerações sobre Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

  O município de Ibema conta hoje com um Hospital Municipal e com duas Unidades básicas de saúde. Nestas contemplam uma Equipe saúde da família e Duas EAP's.

6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

A disponibilização dos dados do SCNES, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo DRAC/SAES.

Período 02/2025

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação						
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**CBOs médicos**	**CBOs enfermeiro**	**CBOs (outros) nível superior**	**CBOs (outros) nível médio**	**CBOs ACS**
Pública (NJ grupo 1)	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	4	3	6	11	7

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão						
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**CBOs médicos**	**CBOs enfermeiro**	**CBOs (outros) nível superior**	**CBOs (outros) nível médio**	**CBOs ACS**
Pública (NJ grupo 1)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	1	0	3	1	0

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 27/03/2026.

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação					
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Pública (NJ grupo 1)	Autônomos (0209, 0210)	1	0	0	0
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	51	53	54	45
	Intermediados por outra entidade (08)	2	0	0	0
	Residentes e estagiários (05, 06)	5	5	5	5

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão					
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Pública (NJ grupo 1)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	3	4	3	5

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 27/03/2026.

- Análises e Considerações sobre Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

  O município ainda tem Uma Unidade de fisioterapia e uma academia de saúde.

  O município possui hoje os seguinte profissionais:

  Hospital com 28 profissionais sendo estes: 09 terceirizados; 13 concursados e 6 contratados;

  UBS com 19 profissionais sendo estes: 11 concursados e 8 contratados

  ESF com 21 profissionais sendo estes: 02 terceirizados; 17 concursados e 2 contratados;

  Secretaria de saúde com 17 profissionais sendo estes: 13 concursados e 4 contratados;

7. Programação Anual de Saúde - PAS

7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores

DIRETRIZ Nº 1 - 1ª Diretriz ¿ Garantia do acesso da população a serviços de saúde de qualidade, mediante estruturação e investimentos na Rede de Serviços da Saúde ¿ Atenção Primária à Saúde e nos serviços da Rede de Urgência e Emergência. (Bloco de Investimento do FNS).

OBJETIVO Nº 1 .1 - Reforma, ampliação e manutenção da estrutura da Unidade Básica de Saúde

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Reforma, ampliação e manutenção da estrutura da Unidade Básica de Saúde	Reforma e ampliação	Percentual	2022	100,00	100,00	100,00	Percentual	50,00	50,00
Ação Nº 1 - reforma									

OBJETIVO Nº 1 .2 - Reforma, ampliação e manutenção da estrutura da UAPSF

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Reforma, ampliação e manutenção da estrutura da UAPSF	Reforma e Ampliação	Percentual	2022	100,00	100,00	100,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - ampliação									

OBJETIVO Nº 1 .3 - Aquisição de câmara de vacina com capacidade de 340 litros para a UAPSF

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Aquisição de câmara de vacina com capacidade de 340 litros para a UAPSF	Aquisição de equipamentos	Percentual	2022	100,00	100,00	Não programada	Percentual		

OBJETIVO Nº 1 .4 - Reforma do hospital

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Reforma do hospital	Garantia do acesso	Percentual	2022	100,00	100,00	Não programada	Percentual		

OBJETIVO Nº 1 .5 - Implantar farmácia na UAPSF

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Implantar farmácia na UAPSF	Garantia do acesso	Percentual	2022	100,00	100,00	Não programada	Percentual		

DIRETRIZ Nº 2 - 2ª Diretriz ¿ Promoção da atenção integral à saúde da população através das Equipes da APS, Saúde da Família e NASF para todos os segmentos populacionais, priorizando as ações para a população mais vulnerável (criança, mulher, adolescentes e jovens, saúde do homem e idosos, seguido da promoção da atenção integral à Saúde Bucal e da adesão à assistência em Redes de Atenção à Saúde a serem implantadas pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo Ministério da Saúde. (Bloco da Atenção Básica do FNS: PAB fixo e variável, PMAQ, especificidades regionais, NASF.

OBJETIVO Nº 2 .1 - Ampliar o número de Equipe Saúde da Família, garantindo uma cobertura de 100% da população.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS

1. Ampliar o número de Equipe Saúde da Família, garantindo uma cobertura de 100% da população.	Cobertura populacional estimada pelas equipes de PSF.	Percentual	2022	100,00	100,00	Não programada	Percentual		

OBJETIVO Nº 2 .2 - Implantar equipe de saúde bucal.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Implantar equipe de saúde bucal.	Cobertura populacional estimada pela equipe de saúde bucal	Percentual	2022	100,00	100,00	100,00	Percentual	50,00	50,00

Ação Nº 1 - implantar

OBJETIVO Nº 2 .3 - Reativar a Sala de Raio x no hospital Municipal

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Reativar a Sala de Raio x no hospital Municipal	Melhoria na qualidade do atendimento	Percentual	2022	100,00	100,00	100,00	Percentual	0	0

Ação Nº 1 - reativar

OBJETIVO Nº 2 .4 - Criar o cargo de coordenador de atenção básica

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Criar o cargo de coordenador de atenção básica	Melhoria da qualidade da atenção primaria	Percentual	2022	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00

Ação Nº 1 - criar

OBJETIVO Nº 2 .5 - Manter o programa Rede Mãe Paranaense de acordo com as diretrizes do Linha Guia

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Manter o programa Rede Mãe Paranaense de acordo com as diretrizes do Linha Guia	Melhoria da qualidade da atenção primária	Percentual	2022	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00

Ação Nº 1 - manter programa

OBJETIVO Nº 2 .6 - Manter o Planifica sus

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Manter o Planifica sus	Melhoria da qualidade e acesso da atenção básica	Percentual	2022	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00

Ação Nº 1 - manter

OBJETIVO Nº 2 .7 - Manter o Programa Mais Médicos vinculado ao PSF

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Manter o Programa Mais Médicos vinculado ao PSF	Melhoria da qualidade e acesso da atenção básica	Percentual	2022	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00

Ação Nº 1 - manter programa

OBJETIVO Nº 2 .8 - Manter o Qualificasus

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Manter o Qualificasus	Garantir recurso para o município	Percentual	2022	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - manter programa									

DIRETRIZ Nº 3 - 3ª Diretriz ¿ Promoção da atenção à Saúde Mental, álcool e outras drogas, seguido da adesão à assistência em Redes de Atenção a serem implantadas pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo Ministério da Saúde.

OBJETIVO Nº 3 .1 - Garantir tratamento adequado e em tempo oportuno.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. qualidade do atendimento	qualidade do atendimento	Percentual		100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - garantir									

OBJETIVO Nº 3 .2 - Manter o Sistema de Central de Leitos

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Qualidade de Atendimento	Qualidade de Atendimento	Percentual	2022	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - manter programa									

OBJETIVO Nº 3 .3 - Estruturar uma equipe de saúde mental

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Estruturar uma equipe de saúde mental	Equipe de atenção à Saúde Mental	Percentual	2022	100,00	100,00	Não programada	Percentual		

OBJETIVO Nº 3 .4 - Manter convênio com o SIM PR

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Manter convênio com o SIM PR	Garantir o acesso	Percentual	2022	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - manter programa									

DIRETRIZ Nº 4 - 4ª. Diretriz ¿ Garantir o acesso da população aos medicamentos da Atenção Básica conforme RENAME (Relação Nacional dos Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica) - Bloco da Assistência farmacêutica

OBJETIVO Nº 4 .1 - Contratar profissional farmacêutico para UAPSF

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Contratar profissional farmacêutico para UAPSF	Assistência Farmacêutica	Percentual	2022	100,00	100,00	Não programada	Percentual		

OBJETIVO Nº 4 .2 - Coordenar a aquisição e distribuição de medicamentos para as unidades, programas e serviços da secretaria de saúde.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Coordenar a aquisição e distribuição de medicamentos para as unidades, programas e serviços da secretaria de saúde.	Assistência Farmacêutica	Percentual	2022	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - coordenar									

OBJETIVO Nº 4 .3 - Normatizar, promover e coordenar a organização da assistência farmacêutica, nos diferentes níveis de atenção a saúde, obedecendo os princípios e diretrizes do SUS.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Normatizar, promover e coordenar a organização da assistência farmaceutica, nos diferentes níveis de atenção a saúde, obedecendo os princípios e diretrizes do SUS.	Assistência Farmacêutica	Percentual	2022	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - normatizar									

OBJETIVO Nº 4 .4 - Atualizar e manter REMUME (relação Municipal de Medicamentos)

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Atualizar e manter REMUME (relação Municipal de Medicamentos)	Assistência Farmacêutica	Percentual	2022	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - atualizar e manter									

DIRETRIZ Nº 5 - 5º. Diretriz ¿ Assegurar a execução das ações de vigilância em saúde, e a integração das equipes da Vigilância Epidemiológica e Sanitária com as equipes Saúde da Família na atenção a vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis, das não transmissíveis e das imunopreveníveis, bem como às emergências; e que juntas fortaleçam a promoção da saúde, a Vigilância em Saúde Ambiental e da Saúde do Trabalhador.

OBJETIVO Nº 5 .1 - Desenvolver o programa municipal de controle da dengue, visando a prevenção de epidemias.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Desenvolver o programa municipal de controle da dengue, visando a prevenção de epidemias.	Numero de casos confirmados e taxa de letalidade	Percentual	2022	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - desenvolver									

OBJETIVO Nº 5 .2 - Investigar 100% dos óbitos infantis, fetais e mulheres em idade fértil.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Investigar 100% dos óbitos infantis, fetais e mulheres em idade fértil.	Percentual de óbitos infantis, fetais, e de mulheres em idade fértil investigados.	Percentual	2022	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - investigar									

OBJETIVO Nº 5 .3 - Manter as coberturas vacinais e a homogeneidade vacinal preconizada pelo Ministério da saúde.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Percentual de óbitos infantis, fetais, e de mulheres em idade fértil investigados.	Percentual de cobertura vacinal por imunobiologico	Proporção	2022	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Percentual de óbitos infantis, fetais, e de mulheres em idade fértil investigados									

OBJETIVO Nº 5 .4 - Curar 100% dos casos diagnosticados de hanseníase entre os casos novos no ano de coorte.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Curar 100% dos casos diagnosticados de hanseníase entre os casos novos no ano de coorte.	Taxa de cura em hanseníase dos casos novos diagnosticado nos anos de coorte.	Percentual	2022	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Curar 100% dos casos diagnosticados de hanseníase entre os casos novos no ano de coorte.									

OBJETIVO Nº 5 .5 - Curar 100% dos casos diagnosticados de tuberculose

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Curar 100% dos casos diagnosticados de tuberculose	Taxa de cura dos casos novos diagnosticados nos anos de coorte.	Percentual	2022	100,00	100,00	100,00	Proporção	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Curar 100% dos casos diagnosticados de tuberculose									

OBJETIVO Nº 5 .6 - Ampliar as notificações de agravos e doenças em saúde do trabalhador em 10% em conformidade com a portaria MS 104/2011

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Ampliar as notificações de agravos e doenças em saúde do trabalhador em 10% em conformidade com a portaria MS 104/2011	Percentual de notificações de agravos e doenças em saúde do trabalhador.	Percentual	2022	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Ampliar as notificações de agravos e doenças em saúde do trabalhador em 10% em conformidade com a portaria MS 104/2011									

OBJETIVO Nº 5 .7 - Ampliar a proporção de amostras de água examinadas para os parâmetros coliformes totais, cloro residual e turbidez.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Ampliar a proporção de amostras de água examinadas para os parâmetros coliformes totais, cloro residual e turbidez.	Número de amostras de água examinados para os parâmetros coliformes totais, cloro residual e turbidez/ano	Percentual	2022	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00

Ação Nº 1 - Ampliar a proporção de amostras de água examinadas para os parâmetros coliformes totais, cloro residual e turbidez.

OBJETIVO Nº 5 .8 - Realizar Campanhas de vacinas. Dia do Homem, Dia da Mulher, Campanha de Teste Rápido

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Realizar Campanhas de vacinas. Dia do Homem, Dia da Mulher, Campanha de Teste Rapido	Promoção a Saúde	Percentual	2022	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00

Ação Nº 1 - Realizar Campanhas de vacinas. Dia do Homem, Dia da Mulher, Campanha de Teste Rapido

OBJETIVO Nº 5 .9 - Realizar projeto saúde na escola trabalhando temas como gravides na adolescência, sexualidade, nutrição

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Realizar projeto saúde na escola trabalhando temas como gravides na adolescência, sexualidade, nutrição	Promoção a Saúde	Percentual	2022	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00

Ação Nº 1 - Realizar projeto saúde na escola trabalhando temas como gravides na adolescência, sexualidade, nutrição

DIRETRIZ Nº 6 - 6ª. Diretriz ¿ Garantir o acesso aos serviços de média e alta complexidade (atenção especializada) e implantar o processo de monitoramento e avaliação dos encaminhamentos conforme classificação de risco dos pacientes. (Bloco da MAC)

OBJETIVO Nº 6 .1 - Implantar a classificação de risco dos pacientes

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Implantar a classificação de risco dos pacientes	Garantia do acesso	Percentual	2022	100,00	100,00	100,00	Percentual	0	0

Ação Nº 1 - Implantar a classificação de risco dos pacientes

OBJETIVO Nº 6 .2 - Garantir o acesso a média e alta complexidade via Central de Leitos aos centros de referencia

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Garantir o acesso a média e alta complexidade via Central de Leitos aos centros de referencia	Garantia do acesso	Percentual	2022	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00

Ação Nº 1 - Garantir o acesso a média e alta complexidade via Central de Leitos aos centros de referencia

DIRETRIZ Nº 7 - 7ª. Diretriz ¿ Garantir o acesso da população aos serviços de Urgência e Emergência, conforme a construção da Rede de Urgência e Emergência que está sendo estruturada em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde e com o Ministério da Saúde.

OBJETIVO Nº 7 .1 - 100% da população informada sobre os serviços do CONSAMU									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2025**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. divulgação sobre o SAMU	Atendimento de urgência e emergência	Percentual	2022	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - 100% da população informada sobre os serviços do CONSAMU									
2. 100% da população informada sobre os serviços de Verificação de óbito (SVO).	Atendimento de verificações de óbito por causas não externas	Percentual	2022	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - 100% da população informada sobre os serviços de Verificação de óbito (SVO).									
3. Agilizar as internações de urgência e emergência reguladas pela central de regulação	Proporção de internações de urgência e emergência reguladas.	Percentual	2022	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Agilizar as internações de urgência e emergência reguladas pela central de regulação									

DIRETRIZ Nº 8 - 8ª. Diretriz - Aperfeiçoamento e fortalecimento da gestão descentralizada e regionalizada, Gestão do Planejamento e da informação em saúde, Gestão do trabalho e da educação na saúde, e aperfeiçoamento e fortalecimento da Gestão Participativa e do Controle Social. (Bloco Gestão do SUS)

OBJETIVO Nº 8 .1 - Manter o funcionamento do ambulatório de gestação de alto risco no município de Cascavel, atendendo os 25 municípios da 10ª RS									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2025**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Manter o funcionamento do ambulatório de gestação de alto risco no município de Cascavel, atendendo os 25 municipios da 10ª RS	Fortalecimento da atenção básica	Percentual	2022	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Manter o funcionamento do ambulatório de gestação de alto risco no município de Cascavel, atendendo os 25 municipios da 10ª RS									

OBJETIVO Nº 8 .2 - Manter convenio com o CISOP									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2025**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Manter convenio com o CISOP	Garantir acesso as consultas de média Complexidade	Percentual	2022	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Manter convenio com o CISOP									

OBJETIVO Nº 8 .3 - Manter convenio com Sistema MV para agendamentos em consultas de alta complexidade									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2025**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Manter convenio com Sistema MV para agendamentos em consultas de alta complexidade	Garantir acesso as consultas, cirurgias e exames de alta Complexidade	Percentual	2022	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Manter convenio com Sistema MV para agendamentos em consultas de alta complexidade									

Demonstrativo da vinculação das metas anualizadas com a Subfunção			
Subfunções	**Descrição das Metas por Subfunção**	**Meta programada para o exercício**	**Resultados**

122 - Administração Geral	Criar o cargo de coordenador de atenção básica	100,00	100,00
	Manter convenio com Sistema MV para agendamentos em consultas de alta complexidade	100,00	100,00
	Manter convenio com o CISOP	100,00	100,00
	Manter o funcionamento do ambulatório de gestação de alto risco no município de Cascavel, atendendo os 25 municipios da 10ª RS	100,00	100,00
	Manter o programa Rede Mãe Paranaense de acordo com as diretrizes do Linha Guia	100,00	100,00
	Manter o Planifica sus	100,00	100,00
	Manter o Programa Mais Médicos vinculado ao PSF	100,00	100,00
	Manter o Qualificasus	100,00	100,00
	qualidade do atendimento	100,00	100,00
	Qualidade de Atendimento	100,00	100,00
	Manter convênio com o SIM PR	100,00	100,00
	Coordenar a aquisição e distribuição de medicamentos para as unidades, programas e serviços da secretaria de saúde.	100,00	100,00
	Normatizar, promover e coordenar a organização da assistência farmaceutica, nos diferentes níveis de atenção a saúde, obedecendo os princípios e diretrizes do SUS.	100,00	100,00
	Garantir o acesso a média e alta complexidade via Central de Leitos aos centros de referencia	100,00	100,00
	divulgação sobre o SAMU	100,00	100,00
	100% da população informada sobre os serviços de Verificação de óbito (SVO).	100,00	100,00
	Agilizar as internações de urgência e emergência reguladas pela central de regulação	100,00	100,00
301 - Atenção Básica	Reforma, ampliação e manutenção da estrutura da Unidade Básica de Saúde	100,00	50,00
	Reforma, ampliação e manutenção da estrutura da UAPSF	100,00	0,00
	Implantar equipe de saúde bucal.	100,00	50,00
	Criar o cargo de coordenador de atenção básica	100,00	100,00
	Manter o programa Rede Mãe Paranaense de acordo com as diretrizes do Linha Guia	100,00	100,00
	Manter o Planifica sus	100,00	100,00
	Manter o Programa Mais Médicos vinculado ao PSF	100,00	100,00
	Manter o Qualificasus	100,00	100,00
	qualidade do atendimento	100,00	100,00
	Qualidade de Atendimento	100,00	100,00
	Manter convênio com o SIM PR	100,00	100,00
	Coordenar a aquisição e distribuição de medicamentos para as unidades, programas e serviços da secretaria de saúde.	100,00	100,00
	Normatizar, promover e coordenar a organização da assistência farmaceutica, nos diferentes níveis de atenção a saúde, obedecendo os princípios e diretrizes do SUS.	100,00	100,00
	Atualizar e manter REMUME (relação Municipal de Medicamentos)	100,00	100,00
	Percentual de óbitos infantis, fetais, e de mulheres em idade fértil investigados.	100,00	100,00
	Curar 100% dos casos diagnosticados de hanseníase entre os casos novos no ano de coorte.	100,00	100,00
	Ampliar as notificações de agravos e doenças em saúde do trabalhador em 10% em conformidade com a portaria MS 104/2011	100,00	100,00
	Realizar Campanhas de vacinas. Dia do Homem, Dia da Mulher, Campanha de Teste Rapido	100,00	100,00
	Realizar projeto saúde na escola trabalhando temas como gravides na adolescência, sexualidade, nutrição	100,00	100,00
	Curar 100% dos casos diagnosticados de tuberculose	100,00	100,00
	Implantar a classificação de risco dos pacientes	100,00	0,00

	Manter o funcionamento do ambulatório de gestação de alto risco no município de Cascavel, atendendo os 25 municipios da 10ª RS	100,00	100,00
	Manter convenio com o CISOP	100,00	100,00
	Manter convenio com Sistema MV para agendamentos em consultas de alta complexidade	100,00	100,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Reativar a Sala de Raio x no hospital Municipal	100,00	0,00
	Manter convenio com Sistema MV para agendamentos em consultas de alta complexidade	100,00	100,00
	Manter convenio com o CISOP	100,00	100,00
	Manter o funcionamento do ambulatório de gestação de alto risco no município de Cascavel, atendendo os 25 municipios da 10ª RS	100,00	100,00
	Garantir o acesso a média e alta complexidade via Central de Leitos aos centros de referencia	100,00	100,00
	divulgação sobre o SAMU	100,00	100,00
	100% da população informada sobre os serviços de Verificação de óbito (SVO).	100,00	100,00
	Agilizar as internações de urgência e emergência reguladas pela central de regulação	100,00	100,00
304 - Vigilância Sanitária	Ampliar a proporção de amostras de água examinadas para os parâmetros coliformes totais, cloro residual e turbidez.	100,00	100,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Desenvolver o programa municipal de controle da dengue, visando a prevenção de epidemias.	100,00	100,00
	Investigar 100% dos óbitos infantis, fetais e mulheres em idade fértil.	100,00	100,00
	Percentual de óbitos infantis, fetais, e de mulheres em idade fértil investigados.	100,00	100,00
	Curar 100% dos casos diagnosticados de hanseníase entre os casos novos no ano de coorte.	100,00	100,00
	Ampliar as notificações de agravos e doenças em saúde do trabalhador em 10% em conformidade com a portaria MS 104/2011	100,00	100,00
	Ampliar a proporção de amostras de água examinadas para os parâmetros coliformes totais, cloro residual e turbidez.	100,00	100,00
	Realizar Campanhas de vacinas. Dia do Homem, Dia da Mulher, Campanha de Teste Rapido	100,00	100,00
	Curar 100% dos casos diagnosticados de tuberculose	100,00	100,00

Demonstrativo da Programação de Despesas com Saúde por Subfunção, Categoria Econômica e Fonte de Recursos

Subfunções	Categoria Econômica	Recursos ordinários - Fonte Livre (R$)	Receita de impostos e de transferência de impostos (receita própria - R$)	Transferências de fundos à Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Federal (R$)	Transferências de fundos ao Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Estadual (R$)	Transferências de convênios destinados à Saúde (R$)	Operações de Crédito vinculadas à Saúde (R$)	Royalties do petróleo destinados à Saúde (R$)	Outros recursos destinados à Saúde (R$)	Total(R$)
0 - Informações Complementares	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
122 - Administração Geral	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
301 - Atenção Básica	Corrente	N/A	5.079.928,33	1.230.000,00	100.000,00	N/A	N/A	N/A	230.000,00	6.639.928,33
	Capital	N/A	39.200,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	39.200,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	N/A	2.595.000,00	N/A	200.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	2.795.000,00
	Capital	N/A	111.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	111.000,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	N/A	363.846,67	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	363.846,67
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
304 - Vigilância Sanitária	Corrente	N/A	58.290,00	12.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70.290,00
	Capital	N/A	1.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	N/A	207.200,00	118.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	325.200,00
	Capital	N/A	1.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.000,00
306 - Alimentação e Nutrição	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 27/03/2026.

- Análises e Considerações sobre Programação Anual de Saúde - PAS

A Programação Anual de Saúde (PAS) aprovada para o exercício de 2025 foi construída de acordo com as diretrizes do Plano Municipal de Saúde e em consonância com as prioridades pactuadas nas instâncias de gestão do SUS. Observa-se que as metas propostas contemplam os principais problemas de saúde identificados no diagnóstico situacional, especialmente no que se refere ao fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, vigilância em saúde, promoção da saúde e melhoria da gestão do sistema.

No processo de monitoramento, destacou-se o empenho das equipes multiprofissionais, a articulação intersetorial e o acompanhamento pelo Conselho Municipal de Saúde, garantindo transparência e participação social. Entretanto, foram identificados desafios relacionados à limitação de recursos financeiros e humanos, além de situações emergenciais que exigiram ajustes na execução das ações.

Considerações Finais

A PAS aprovada representa um avanço na organização das ações e serviços de saúde do município, ao alinhar metas realistas e compatíveis com a capacidade de execução da gestão local. A consolidação do processo de planejamento demonstra o comprometimento com a melhoria da qualidade do cuidado prestado à população e o fortalecimento do SUS em âmbito municipal.

Recomenda-se, para os próximos ciclos:

a)Intensificar a qualificação dos sistemas de informação para melhor monitoramento dos indicadores;

b)Ampliar a integração entre os diferentes níveis de atenção e vigilância em saúde;

c)Garantir maior investimento em educação permanente das equipes;

d)Buscar estratégias para captação de recursos complementares e otimização da aplicação orçamentária;

e)Fortalecer ainda mais a participação do controle social no acompanhamento da execução da programação.

Conclui-se que a execução da Programação Anual de Saúde aprovada constitui importante instrumento de gestão, sendo fundamental a continuidade do processo avaliativo e a retroalimentação com vistas ao próximo ciclo de planejamento.

8. Indicadores de Pactuação Interfederativa

O processo de Pactuação Interfederativa de Indicadores foi **descontinuado** com a revogação da Resolução nº 8/2016 a partir da publicação da Resolução de Consolidação CIT nº 1/2021. Para mais informações, consultar a **Nota Técnica nº 20/2021-DGIP/SE/MS**

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 27/03/2026.

9. Execução Orçamentária e Financeira

A disponibilização dos dados do SIOPS, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo FNS/SE/MS.

9.1. Execução da programação por fonte de recurso, subfunção e categoria econômica

Despesa Total em Saúde por Fonte e Subfunção

Subfunções		Recursos Ordinários - Fonte Livre	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Transferências de Convênios destinadas à Saúde	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	Outros Recursos Destinados à Saúde	TOTAL
301 - Atenção Básica	Corrente	0,00	5.501.703,40	971.779,66	224.887,64	0,00	0,00	0,00	0,00	121.913,05	6.820.283,75
	Capital	0,00	320.055,96	88.450,55	1.461.519,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.026,17
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	0,00	2.252.949,23	0,00	182.542,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435.492,16
	Capital	0,00	0,00	0,00	32.814,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	34.314,82
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	0,00	160.063,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.063,90
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	Corrente	0,00	36.121,79	30.478,70	18.944,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.544,76
	Capital	0,00	0,00	0,00	32.240,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.240,93
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	0,00	77.814,30	116.587,83	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.187,13
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	8.348.708,58	1.207.296,74	1.953.735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	123.413,05	11.633.153,62

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Data da consulta: 09/03/2026.

9.2. Indicadores financeiros

Indicadores do Ente Federado		
Indicador		Transmissão
		Única
1.1	Participação da receita de impostos na receita total do Município	7,33 %
1.2	Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município	87,39 %
1.3	Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município	7,61 %
1.4	Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município	43,07 %
1.5	Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município	5,80 %
1.6	Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município	61,69 %
2.1	Despesa total com Saúde, em R$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante	R$ 1.814,79
2.2	Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde	48,67 %
2.3	Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde	1,68 %
2.4	Participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com Saúde	9,28 %
2.5	Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde	16,82 %
2.6	Despesas com Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00 %
3.1	Participação das transferências para a Saúde em relação à despesa total do Município com saúde	28,48 %
3.2	Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012	26,20 %

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Data da consulta: 09/03/2026.

9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.029.000,00	4.112.956,66	3.725.126,07	90,57
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	845.000,00	845.000,00	790.649,39	93,57
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	320.000,00	320.000,00	309.435,86	96,70
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.174.000,00	1.174.000,00	682.168,24	58,11
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.690.000,00	1.773.956,66	1.942.872,58	109,52
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.550.000,00	28.050.715,69	27.632.242,67	98,51
Cota-Parte FPM	18.200.000,00	19.700.715,69	18.943.956,19	96,16
Cota-Parte ITR	550.000,00	550.000,00	266.575,39	48,47
Cota-Parte do IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.173.705,76	97,81
Cota-Parte do ICMS	6.500.000,00	6.500.000,00	7.142.889,59	109,89
Cota-Parte do IPI - Exportação	100.000,00	100.000,00	105.115,74	105,12
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	30.579.000,00	32.163.672,35	31.357.368,74	97,49

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.119.128,34	6.228.915,91	5.821.759,36	93,46	5.673.071,76	91,08	5.664.267,82	90,94	148.687,60
Despesas Correntes	5.079.928,34	5.770.784,86	5.501.703,40	95,34	5.492.683,28	95,18	5.483.879,34	95,03	9.020,12
Despesas de Capital	39.200,00	458.131,05	320.055,96	69,86	180.388,48	39,37	180.388,48	39,37	139.667,48
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.706.000,00	2.620.363,72	2.252.949,23	85,98	2.235.506,16	85,31	2.230.014,10	85,10	17.443,07
Despesas Correntes	2.595.000,00	2.509.363,72	2.252.949,23	89,78	2.235.506,16	89,09	2.230.014,10	88,87	17.443,07
Despesas de Capital	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	363.846,67	353.846,67	160.063,90	45,24	152.263,79	43,03	144.827,40	40,93	7.800,11
Despesas Correntes	363.846,67	353.846,67	160.063,90	45,24	152.263,79	43,03	144.827,40	40,93	7.800,11
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	59.290,00	63.890,00	36.121,79	56,54	36.121,79	56,54	36.121,79	56,54	0,00
Despesas Correntes	58.290,00	62.890,00	36.121,79	57,44	36.121,79	57,44	36.121,79	57,44	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	208.200,00	180.200,00	77.814,30	43,18	77.814,30	43,18	77.814,30	43,18	0,00
Despesas Correntes	207.200,00	179.200,00	77.814,30	43,42	77.814,30	43,42	77.814,30	43,42	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.456.465,01	9.447.216,30	8.348.708,58	88,37	8.174.777,80	86,53	8.153.045,41	86,30	173.930,78

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.348.708,58	8.174.777,80	8.153.045,41
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	132.751,59	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.215.956,99	8.174.777,80	8.153.045,41
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.703.605,31
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.512.351,68	3.471.172,49	3.449.440,10
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	26,20	26,06	26,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	4.703.605,31	8.215.956,99	3.512.351,68	195.663,17	132.751,59	0,00	0,00	195.663,17	0,00	3.645.103,27
Empenhos de 2024	4.381.105,43	7.427.487,54	3.046.382,11	199.919,30	0,00	0,00	194.097,54	0,00	5.821,76	3.040.560,35
Empenhos de 2023	3.754.829,97	7.075.105,88	3.320.275,91	54.955,13	0,00	0,00	52.173,95	0,00	2.781,18	3.317.494,73

Empenhos de 2022	3.509.683,52	6.338.261,66	2.828.578,14	23.565,97	13.188,50	0,00	21.036,27	0,00	2.529,70	2.839.236,94
Empenhos de 2021	3.095.262,78	5.150.843,84	2.055.581,06	89.107,17	0,00	0,00	88.573,62	0,00	533,55	2.055.047,51
Empenhos de 2020	2.351.459,74	4.164.457,01	1.812.997,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812.997,27
Empenhos de 2019	2.359.599,40	4.076.914,60	1.717.315,20	121.283,53	0,00	0,00	121.283,53	0,00	0,00	1.717.315,20
Empenhos de 2018	2.224.612,66	4.364.471,72	2.139.859,06	9.309,64	9.309,64	0,00	6.839,85	0,00	2.469,79	2.146.698,91
Empenhos de 2017	2.089.149,08	3.634.825,41	1.545.676,33	7.231,86	0,00	0,00	5.222,86	0,00	2.009,00	1.543.667,33
Empenhos de 2016	2.032.459,81	3.072.352,41	1.039.892,60	3.035,17	0,00	0,00	3.035,17	0,00	0,00	1.039.892,60
Empenhos de 2015	1.875.243,67	2.977.479,88	1.102.236,21	4.950,56	4.379,66	0,00	4.734,50	0,00	216,06	1.106.399,81
Empenhos de 2014	1.721.037,66	2.871.780,86	1.150.743,20	1.104,53	0,00	0,00	1.104,53	0,00	0,00	1.150.743,20
Empenhos de 2013	1.706.484,21	2.303.135,48	596.651,27	14,01	0,00	0,00	14,01	0,00	0,00	596.651,27

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	1.690.100,00	2.819.581,34	3.278.488,21	116,28
Provenientes da União	1.360.000,00	1.454.253,58	1.468.317,60	100,97
Provenientes dos Estados	100.100,00	1.135.327,76	1.688.257,56	148,70
Provenientes de Outros Municípios	230.000,00	230.000,00	121.913,05	53,01
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	199.900,00	199.900,00	130.635,73	65,35
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	1.890.000,00	3.019.481,34	3.409.123,94	112,90

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	1.560.000,00	4.031.943,70	2.746.637,51	68,12	1.247.017,03	30,93	1.235.883,58	30,65	1.499.620,48
Despesas Correntes	1.560.000,00	2.032.755,27	1.196.667,30	58,87	1.179.930,73	58,05	1.168.797,28	57,50	16.736,57
Despesas de Capital	0,00	1.999.188,43	1.549.970,21	77,53	67.086,30	3,36	67.086,30	3,36	1.482.883,91
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	200.000,00	309.114,15	216.857,75	70,15	216.857,75	70,15	216.857,75	70,15	0,00
Despesas Correntes	200.000,00	250.841,73	182.542,93	72,77	182.542,93	72,77	182.542,93	72,77	0,00
Despesas de Capital	0,00	58.272,42	34.314,82	58,89	34.314,82	58,89	34.314,82	58,89	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	12.000,00	363.457,33	81.663,90	22,47	81.363,90	22,39	81.363,90	22,39	300,00
Despesas Correntes	12.000,00	269.752,05	49.422,97	18,32	49.122,97	18,21	49.122,97	18,21	300,00
Despesas de Capital	0,00	93.705,28	32.240,93	34,41	32.240,93	34,41	32.240,93	34,41	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	118.000,00	158.763,45	117.372,83	73,93	117.372,83	73,93	117.372,83	73,93	0,00
Despesas Correntes	118.000,00	148.763,45	117.372,83	78,90	117.372,83	78,90	117.372,83	78,90	0,00
Despesas de Capital	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	1.890.000,00	4.863.278,63	3.162.531,99	65,03	1.662.611,51	34,19	1.651.478,06	33,96	1.499.920,48

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA(XLI) = (IV + XXXIII)	6.679.128,34	10.260.859,61	8.568.396,87	83,51	6.920.088,79	67,44	6.900.151,40	67,25	1.648.308,08
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	2.906.000,00	2.929.477,87	2.469.806,98	84,31	2.452.363,91	83,71	2.446.871,85	83,53	17.443,07
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	363.846,67	353.846,67	160.063,90	45,24	152.263,79	43,03	144.827,40	40,93	7.800,11

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	71.290,00	427.347,33	117.785,69	27,56	117.485,69	27,49	117.485,69	27,49	300,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	326.200,00	338.963,45	195.187,13	57,58	195.187,13	57,58	195.187,13	57,58	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	10.346.465,01	14.310.494,93	11.511.240,57	80,44	9.837.389,31	68,74	9.804.523,47	68,51	1.673.851,26
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.890.000,00	4.863.278,63	3.364.714,42	69,19	1.864.793,94	38,34	1.853.660,49	38,12	1.499.920,48
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	8.456.465,01	9.447.216,30	8.146.526,15	86,23	7.972.595,37	84,39	7.950.862,98	84,16	173.930,78

FONTE: SIOPS, Paraná19/02/26 07:39:11
1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3 - Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

9.4. Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo, segundo bloco de financiamento e programa de trabalho

Bloco de Financiamento	Programas de Trabalho	Valor Transferido em 2025 (Fonte: FNS)	Valor Executado
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10122512100UW - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	R$ 343,74	R$ 0,00
	10301511900UC - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	R$ 276.276,00	R$ 0,00
	103015119219A - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	R$ 929.505,93	R$ 0,00
	10301511921CE - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - NACIONAL	R$ 783,40	R$ 0,00
	10303511720AH - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	R$ 12.000,00	R$ 0,00
	10303511720K5 - APOIO AO USO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS NO SUS	R$ 3.730,80	R$ 0,00
	10304512320AB - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R$ 11.000,00	R$ 0,00
	10305512300UB - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	R$ 118.404,00	R$ 0,00
	10305512320AL - APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R$ 22.299,40	R$ 0,00
	10306513320QH - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	R$ 36.454,73	R$ 0,00

Fonte: Fundo Nacional de Saúde (FNS)

1 – Os valores pagos em outro exercício fiscal mesmo tendo sua memória de cálculo e ano anterior, não estarão sendo computados para aquela prestação de contas.
2 – Para efeitos de despesa executada deve ser considerada a despesa empenhada no exercício fiscal.

9.5. Relatório de Execução de Recursos Repassados por Emenda Parlamentar

Não há informações cadastradas para o período do Relatório de Execução de Recursos Repassados por Emenda Parlamentar.

- Análises e Considerações sobre Execução Orçamentária e Financeira

  As atividades de Saúde do Município de Ibema são financiadas por recursos Federais mediante convenio e repasse Fundo a Fundo; os planos de convênios foram repassados conforme cronograma de desembolso financeiro do Governo Federal e foram utilizados de acordo com o plano de aplicação pactuado;

10. Auditorias

Não há informações cadastradas para o período das Auditorias.
Fonte: Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SISAUD-SUS)
Data da consulta: 27/03/2026.

Outras Auditorias

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 27/03/2026.

- Análises e Considerações sobre Auditorias

não houve

11. Análises e Considerações Gerais

Apresentado neste relatório os resultados qualitativos e quantitativos no processo do cuidar da saúde, acompanhado e avaliado os indicadores no ano de 2025.

12. Recomendações para o Próximo Exercício

- Análises e Considerações sobre Recomendações para o Próximo Exercício

Aprimorar os sistemas de informação em saúde

¿ Garantir maior qualidade, completude e atualização dos registros (e-SUS, SIAB, SIM, SINAN, SIH/SUS).

¿ Capacitar as equipes quanto ao uso correto das ferramentas, evitando subnotificação.

2. Fortalecer a Atenção Primária à Saúde (APS)

¿ Intensificar as ações de prevenção e acompanhamento de condições crônicas como hipertensão, diabetes e transtornos mentais.

¿ Ampliar o acompanhamento de grupos prioritários: gestantes, crianças, idosos e pessoas com deficiência.

3. Investir em educação permanente das equipes

¿ Promover treinamentos periódicos em protocolos assistenciais, vigilância em saúde e humanização do cuidado.

¿ Incentivar a troca de experiências entre equipes e setores.

4. Ampliar a integração intersetorial

¿ Estreitar parcerias com educação, assistência social e outros setores para enfrentar determinantes sociais da saúde.

¿ Desenvolver ações conjuntas de promoção da saúde (alimentação saudável, atividade física, prevenção da violência).

5. Melhorar a gestão orçamentária e financeira

¿ Planejar a alocação de recursos com base nos indicadores epidemiológicos.

¿ Buscar fontes adicionais de financiamento estadual e federal, bem como parcerias institucionais.

6. Fortalecer a participação e o controle social

¿ Garantir maior envolvimento do Conselho Municipal de Saúde no acompanhamento das metas da PAS.

¿ Estimular a participação da comunidade nos espaços de escuta e avaliação dos serviços.

7. Monitorar e avaliar continuamente os resultados

¿ Estabelecer cronogramas de monitoramento trimestral dos indicadores e metas.

¿ Utilizar os resultados para retroalimentar a próxima Programação Anual de Saúde.

EROILDA ALVES DE OLIVEIRA
Secretário(a) de Saúde
IBEMA/PR, 2025

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO: PARANA
MUNICÍPIO: IBEMA
Relatório Anual de Gestão - 2025

Parecer do Conselho de Saúde

Identificação

- Considerações:

APROVADO

Introdução

- Considerações:

APROVADO

Dados Demográficos e de Morbimortalidade

- Considerações:

APROVADO

Dados da Produção de Serviços no SUS

- Considerações:

APROVADO

Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

- Considerações:

APROVADO

Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

- Considerações:

APROVADO

Programação Anual de Saúde - PAS

- Considerações:

APROVADO

Indicadores de Pactuação Interfederativa

- Considerações:

Sem Parecer

Execução Orçamentária e Financeira

- Considerações:

APROVADO

Auditorias

- Considerações:

NÃO HOUVE

Análises e Considerações Gerais

- Parecer do Conselho de Saúde:

APROVADO

Recomendações para o Próximo Exercício

- Considerações:

APROVADO

Status do Parecer: Aprovado

IBEMA/PR, 27 de Março de 2026

Conselho Municipal de Saúde de Ibema